

高血压病治疗中的药物相互作用

河南中医学院 席时毕

(邮政编码450003)

本文以临床常用降压药、利尿剂、 β 阻滞剂、钙拮抗剂为主,就降压药之间及降压药和其它经常配伍用药间的相互作用和副作用作一综述,供临床用药时参考。

利尿剂:

1.利尿剂和其它降压药的相互作用和副作用:

(1)双氢克尿塞和心得安合用曾作为降压治疗的基础用药。近年发现^[1、2、3]两者合用可引起血浆胆固醇、甘油三酯和极低密度脂蛋白(VLDL)增高,高密度脂蛋白(HDL)降低,潜在性地增加冠心病危险性,故冠心病患者两药合用应谨慎。

治疗:一般治疗:休息,防止过劳。病因治疗用吗啡肼及改善心肌细胞代谢剂。依心律紊乱的不同类型选用异搏定、慢心律、利多卡因、阿托品、普鲁卡因胺等。心电监护。心跳骤停、室速(VT)、室颤(VF)、阿斯综合征发作胸外按摩,经食道左室起搏,电除颤等。激素治疗组:轻型病例口服强的松30mg,1/早,10~15天。重型氢考200~400mg,或地塞米松20~30mg加入葡萄糖液中静滴,1/日,10~15天。对照组只用一般治疗。临床治愈后渐减至停,否则再用1疗程无效不再用。

疗效与转归:激素组40例中37例临床痊愈出院,3例无效。对照组31例中20例痊愈出院,10例无效,1例恶化猝死。经统计学处理,两者有极显著差异($P<0.01$)。

猝死病例,女20岁。阵发心悸入院,无心衰,心电图呈多形室早,住院1周进餐后猝死。尸解:心重270克,心腔松软,镜下见心肌纤维变性,局灶坏死,间质内多数淋巴细胞浸润。病理诊断:病毒性心肌炎。

体会:基层医院,诊断主要根据感冒后

(2)利尿剂和血管紧张素转换抑制剂(ACEI)巯甲丙脯酸联合用药,能有效地控制高血压,其总有效率达86%。^[4]但对长期应用利尿剂患者加用较大剂量的ACEI时,由于肾素-血管紧张素系统的作用被阻断,出现血压明显下降,严重者甚至出现休克。另外,ACEI有潴钾作用,与安体舒通等保钾利尿剂合用,可致高钾血症,对伴有肾功能不全者,两药合用尤应慎重。

(3)利尿剂和交感神经抑制剂(可乐宁、甲基多巴)合用,因利尿剂可消除可乐宁等的水钠潴留作用,增强降压效果。但对老年高血压者,两药合用时可致血压过低,

心悸气促,心电图存在一般性心律失常,ST-T改变。少数呈恶性室性心律失常,心跳停止,阿斯综合征发作。GOT高,抗链“O”正常,除外其它类心脏病,诊断可成立。靠其临床表现可分为轻、重两型。病人可同时存在两种以上心律紊乱。重型实质上是恶性室性心律失常,病情进展迅速,治疗不及时可致命甚至猝死。猝死者抢救中记录到VF,可说明由室性心律紊乱所致。本病以青年患病为主,临床表现轻重悬殊大,无特效治疗方法。本组40例试用激素治疗,与对照组相比临床治愈率有非常显著差异($P<0.01$)。似说明一般治疗加激素,对心律失常型病毒性心肌炎效果好。对激素的使用有争议^[1、2],有的认为本病急性期,激素抑制抗体干扰素合成,促进病毒繁殖扩散,不主张用。晚近一些学者则认为激素可使心肌炎症水肿及强烈的免疫反应消除和减轻,故主张应用。尤其重症型病毒性心肌炎疗效更佳。对轻型心律失常型病毒性心肌炎

(下转第90页)

应加注意。

2. 利尿剂与其它配伍药物的相互作用和副作用:

(1)、利尿剂和降糖药物不宜合用, 因噻嗪类利尿剂和速尿可降低糖耐量, 使血糖升高, 降低降糖药物的降糖作用, 所以伴有高血压的糖尿病患者不宜两药并用^[8, 9]。

(2)、利尿剂和非甾醇抗炎药消炎痛合用可产生拮抗作用。已知前列腺素 A_2 和 E_2 促进尿钠排泄, 而消炎痛可抑制前列腺素的合成, 影响利尿剂的利尿降压作用^[7, 8]。

(3)、利尿剂和消胆胺(Colestyramine)不宜合用, 因消胆胺阻碍利尿剂在肠道内吸收。如给噻嗪类利尿剂前后2小时内、服用消胆胺8g, 60%左右的利尿剂不能被吸收^[8]。

(4)、利尿剂安体舒通与生胃酮合用有拮抗作用。生胃酮具有盐皮质激素的类似性质, 可引起水钠潴留和血压升高, 故可对抗醛固酮及安体舒通的利尿作用, 因此两药不宜联合应用^[8]。

(5)、利尿剂速尿与氨基甙类抗生素合用可促进对听神经的损害, 与头孢菌素类或氨基甙类合用可增加对肾的毒性作用, 因此不宜长期联合用药^[3, 8]。

β—阻滞剂:

1. β—阻滞剂与其它降压药物的相互作用和副作用。

1. β—阻滞剂与可乐宁不宜合用, 因可乐宁的降压效应可被β阻滞剂对抗。另外两者合用时, 若先停用可乐宁, 可出现血压反跳现象。其原因可能由于阻断了周围肾上腺素的β舒血管作用, 使α受体兴奋作用占优势, 从而使血压升高。因此两者合用最好避免, 若已合用, 停药时应先停β—阻滞剂, 以防血压反跳^[8, 9]。

(2) β—阻滞剂与哌唑嗪合用, 可加重哌唑嗪的首剂效应, 即可引起急性体位性低血压和心动过速等, 这可能是β—阻滞剂抑制哌唑嗪的代谢所致^[8, 9]。因此两药合用时应多加观察。

(3)、β—阻滞剂与钙拮抗剂, 尤其是心得安和异搏定合用后, 由于心得安和异搏定均有降低心肌收缩力和延长房室传导的作用, 因此可出现低血压, 心力衰竭、心动过缓和房室传导阻滞, 对有心力衰竭、心动过缓的高血压患者应避免联合用药。有人报道氨酰心安(Atenolol)和硝苯吡啶合用, 发生严重低血压^[8]。口服硫氮呋酮和氨酰心安致窦性停搏^[11]。

2. β阻滞剂与其它配伍药物的相互作用和副作用:

(1) β—阻滞剂不宜与消炎痛合用, 因消炎痛抑制前列腺素的合成, 使血压升高, 而β阻滞剂可刺激前列腺素合成, 产生降压作用, 因而二者合用相互拮抗, 影响降压效果^[7, 8]。

(2)、β阻滞剂与甲氧咪胍合用时, 由于甲氧咪胍可与肝细胞内的细胞色素P450相结合, 影响心得安在肝内代谢, 使其半衰期延长, 血浆浓度升高, 易出现心动过缓等副作用。有人报道心得安和甲氧咪胍合用后, 心得安血浆浓度增加3~6倍, 血浆药一时曲线下面积(AUC)增加34%^[8]。

(3) β—阻滞剂和苯巴比妥不宜合用, 因苯巴比妥是肝药物诱导剂, 由于肝脏的首过作用使β阻滞剂在肝脏的代谢清除率增加, 半衰期缩短, 降低β—阻滞剂的降压效果^[8, 9, 10]。

(4)、β阻滞剂与地高辛合用: 心得安降低心肌耗氧量, 对缺血心肌有保护作用, 但也严重的抑制心肌收缩, 而地高辛能增加心肌收缩性, 所以二者合用对高血压伴有心脏缺血或心衰患者是适宜的。二者合用对心房颤动的心率控制也有良好的疗效, 但因两药合用常可出现心动过缓、房室传导阻滞, 故只有在心室率较快者, 而单独用地高辛控制心率不满意时, 才考虑两药并用^[9]。

钙拮抗剂:

1. 钙拮抗剂与其它降压药物的相互作用

和副作用:

(1) 钙拮抗剂与血管紧张素转换酶抑制剂(疏甲丙脯酸)合用,因两者对周围血管均有扩张作用,对降压有协同作用,并可减少副作用。如钙拮抗剂硝苯吡啶可使心率加快,消除疏甲丙脯酸因抑制交感神经引起的心率变慢^[10]。但对老年高血压患者,两药合用若剂量偏大,可导致血压过低,应注意。

(2) 钙拮抗剂硝苯吡啶与甲基多巴合用对重症高血压病的治疗有协同作用,主要是协同降低外周血管阻力,使血压下降^[12]。

2. 钙拮抗剂与其它配伍用药的相互作用和副作用:

(1)、钙拮抗剂异搏定和地高辛合用,对控制室上性心动过速和减慢快速房颤有协同作用。但由于异搏定使肾对地高辛清除率下降40~53%,使血浆地高辛浓度增加70%,易引起洋地黄中毒,故两者不宜长期合用^[10]。

硝苯吡啶和硫氮革酮与地高辛合用,也可使血浆地高辛浓度增加。

(2) 异搏定和奎尼丁合用,主要用于

防治室上性快速心律失常,但由于两药对 α_1 和 α_2 受体均有阻滞作用,合用后可引起血压显著下降,所以两药合用时,应减少用药剂量,密切观察血压^[13]。

参考文献

1. Weinberger MH. Am J Med 1988; 80 (2A): 64
2. 洪中立. 新药与临床 1988; 7(5): 285
3. 国府达郎. 临床杂志内科 1983; 69(3): 473
4. 李锦萍等. 中华心血管病杂志 1981; 9(4): 252
5. Wood AJ. Hypertension 1988; 11 (suppl II): 21
6. Frishmcm WH Hypertension 1983; (suppl II): 1
7. Outes JA. Hypertension 1988; 11 (suppl I): 116
8. 陈秋潮,等. 新药与临床 1983; (22): 27
9. 田海明,等. 实用内科杂志 1983; 6(3): 163
10. 杨松令. 实用内科杂志 1987; 7(9): 502
11. 马建强. 实用内科杂志 1988; 8(1): 44
12. Guazzi, et al. Circulation 1980; 81(5): 913
13. 倪延枢. 实用内科杂志 1988; 8(2): 91

口服氯丙嗪治疗心衰

河南省商丘卫校 宋 斌

(邮政编码 476100)

有报道肌注氯丙嗪5~10 mg治疗急性左心衰竭、急性肺水肿可在15分钟左右缓解。本人近来试以口服方法治疗19例慢性较轻的心衰患者,取得了良好的效果。现作以总结如下。

19例中有6例高血压性心脏病,13例慢性肺心病。年龄都在50岁以上。

一、氯丙嗪治疗心衰的机理:

氯丙嗪能阻断肾上腺能 α 受体,扩张外周血管,解除小动脉及小静脉痉挛,从而减轻了心脏的前、后负荷,迅速改善心脏功

能。尤其是对高血压心脏病,氯丙嗪又可降压、所以疗效较好。其次,氯丙嗪能阻断网状上行激动系统中的肾上腺素能 α 受体,使患者镇静、解除其焦虑和痛苦,这对减轻心脏的负荷,减少心肌耗氧量都是有利的。氯丙嗪既能扩张动脉、又能扩张静脉,扩张静脉的作用大于扩张动脉的作用。使升高的左室充盈压显著下降;并使回心血量减少,右室输出量下降,肺水肿减轻。口服氯丙嗪在体内作用时间长,所以睡前给药能预防心源性哮喘的发作^[2]。